

居宅サービス計画書（第1表）

作成年月日	令和8年4月15日	計画作成者氏名	介護支援専門員 山田 太郎
利用者氏名	田中 一郎 様	事業所名	ケアプランセンター〇〇
生年月日	昭和3年（90歳）	性別	男
住所	〇〇市〇〇町4-5-6		
要介護状態区分	要介護1	区分支給限度基準額	16,765単位 [継続]

利用者及び家族の生活に対する意向

本人意向：

「物忘れが増えて不安だが、住み慣れたこの家で暮らし続けたい。自分で簡単なご飯を作ったり、庭の手入れをするのが生きがい」

家族意向（長男）：

「遠方に住んでいるため毎日は通えない。父の認知症の進行を防ぎ、火不始末や栄養の偏りが無いよう専門家の支援をお願いしたい」

介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定

なし

総合的な援助の方針

認知症の初期症状（軽度認知障害～初期段階）による記憶力低下がみられ、火不始末の懸念から調理機会が減少し、栄養バランスの悪化と意欲低下の兆候がみられる。本人の「自宅で暮らしたい」「調理をしたい」という強い意向を尊重し、①ヘルパーの共食・調理同行による認知機能の維持・火気安全の確保、②栄養状態の改善による体力維持、③デイサービスでの他者交流によるBPSD（周辺症状）の予防、を3本柱として在宅生活の継続を支援する。

【緊急時連絡先】

長男：田中 〇〇（携帯 090-▲▲▲▲-▲▲▲▲）／主治医：▲▲クリニック（電話 ▲▲-▲▲▲▲）

※I Hコンロ導入済、内服は一包化。発熱・体調不良時は各サービス事業所およびケアマネジャーへ速やかに連絡。

生活援助中心型の算定理由

該当なし

同意欄

上記計画について説明を受け、内容に同意し交付を受けました。

令和8年4月15日

利用者署名：田中 一郎

居宅サービス計画書（第2表）

【生活全般の解決すべき課題（ニーズ）と援助目標・内容】

【課題分析（アセスメント）の要約】			
直近3か月で軽度の記憶障害が進行。コンロの消し忘れが2回発生し、長男の勧めでIHに変更したが、操作方法に混乱し自炊を中断。その結果、レトルト食品中心となり体重が3ヶ月で2kg減少（48kg→46kg）。「また料理をしたい」という意欲があり、手順の口頭指示や促し（見守りの援助）があれば、安全に調理行為が可能である。この意欲（ストレングス）を引き出すことが廃用予防・BPSD予防の鍵となる。			
生活全般の解決すべき課題 （ニーズ）・〔課題分析〕	長期目標 （期間）	短期目標 （期間）/ ※評価指標	サービス内容・頻度・事業所
1. 調理困難と栄養バランス偏り 火気使用への不安と調理手順の混乱により栄養バランスが偏っている。 〔課題分析〕 認知機能低下による手順の混乱が調理の阻害因子。段階的な促しで実施可能。	安全な調理環境のもとで3食の栄養バランスを整え、現在の体重を維持する。 (R8.4.15 ～ R8.10.14)	週3回、訪問介護員と一緒にメニューを決め、促しを受けながら簡単な副菜の調理や配膳を安全に行うことができる。 (R8.4.15 ～ R8.7.14) ※評価指標：体重の推移（月1回）、食事摂取量（3食完食の日数）、火の不始末件数（0件）	【訪問介護（生活援助）】 共生型調理・配膳支援（見守り・同行調理） 事業所：ヘルパーステーション〇〇 頻度：週3回（月・水・金）
2. 刺激減少と認知症進行リスク 日中の独居時間が長く、刺激の減少から認知症状の進行リスクがある。 〔課題分析〕 独居による他者交流の機会喪失が進行を加速させている。役割の創出で改善。	他者との交流を楽しみ、季節感のある生活を笑顔で送る。 (R8.4.15 ～ R8.10.14)	週2回デイサービスに休まず通い、レクリエーションや園芸活動に自発的に参加できる。 (R8.4.15 ～ R8.7.14) ※評価指標：デイサービス出席率（90%以上）、活動への参加意欲（連絡帳での確認）	【通所介護】 認知症対応型・認知機能特化レク、園芸活動 事業所：デイサービス▲▲ 頻度：週2回（火・木）
インフォーマルサポート	長男が隔週土曜日に訪問し、日用品のまとめ買いと冷蔵庫内の賞味期限チェックを実施。隣人が回覧板の受け渡し時に声かけ。		

居宅サービス計画書（第3表）

【週間サービス計画表】

時間帯	月	火	水	木	金	土	日
9:30 ～ 16:30		通所介護 デイサービス ▲▲ (認知機能レ ク・園芸)		通所介護 デイサービス ▲▲ (認知機能レ ク・園芸)		【インフォーマ ル】 長男訪問 (隔週・まとめ 買い・冷蔵庫 チェック)	自主的な 庭の手入れ
16:30 - 17:30	訪問介護 調理・配膳支 援		訪問介護 調理・配膳支 援		訪問介護 調理・配膳支 援		
その他							

モニタリング	毎月1回、自宅へ訪問して面接を行う。体重測定、食事摂取記録、認知症状（周辺症状）の有無を評価指標に基づき確実に確認する。3か月後に短期目標の進捗を踏まえて見直しを行う。
--------	--